

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Γενικά: Ως επιληπτική κρίση ορίζεται η σύγχρονη παροξυσμική φλοιική εκφόρτιση των νευρώνων, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της φυσιολογικής εγκεφαλικής λειτουργίας.

Μπορεί να εκδηλωθεί ως κινητικό φαινόμενο (σπασμοί) ή ως αισθητικό ή ως νοητική και ψυχική δυσλειτουργία. Οι κρίσεις μπορεί να είναι μεμονωμένες ή υποτροπιάζουσες, αναλόγως εάν ο εγκέφαλος είναι δομικά - ανατομικά φυσιολογικός ή έχει υποστεί προσβολή από κάποιον βλαπτικό παράγοντα (αιμάτωμα, τοξική ουσία, νεοπλασματική εξεργασία, κ.ά.).

Η διάγνωση της επιληψίας προϋποθέτει τουλάχιστον δύο (2) επεισόδια επιληπτικών κρίσεων, που δεν οφείλονται σε γνωστή παθολογική κατάσταση και που δεν προκαλούνται από άμεσο αναγνωρίσιμο και πιθανώς αναστρέψιμο αίτιο (π.χ. μεταβολική διαταραχή, όπως υπογλυκαιμία, υπονατρία, υπασβεστιαιμία, τοξικά και αγγειακά αίτια, λοίμωξη, κ.λπ.).

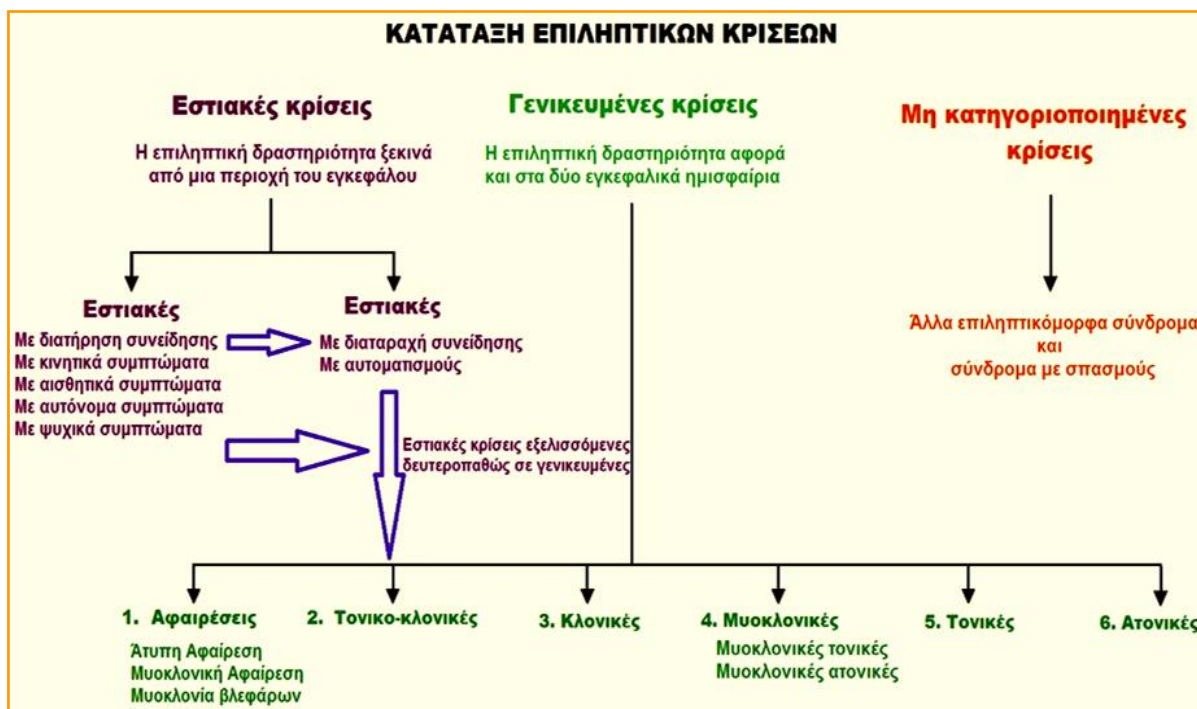
Οι χρόνιες υποτροπιάζουσες επιληπτικές κρίσεις ορίζουν το «**επιληπτικό σύνδρομο**».

Κλινική εξέταση: Αξιολογείται η κατάσταση του ασθενούς μετά το επιληπτικό επεισόδιο (ληθαργικός, διεγερτικός, απώλεια τόνου σφιγκτήρων, κ.ά.). Ελέγχουμε αν ο ασθενής υπέστη τραυματική κάκωση (κάταγμα) ή ΚΕΚ κατά τη διάρκεια του παρόντος ή άλλου επεισοδίου.

Ιστορικό: Λαμβάνουμε ένα σύντομο ιστορικό με σαφή περιγραφή του συμβάντος από τον ασθενή - εφόσον αυτό είναι εφικτό - ή από τους παριστάμενους στο συμβάν ή τους οικείους (χαρακτήρας επεισοδίου, τρόπος έναρξης, διάρκεια επεισοδίου, κατάσταση προς της κρίσης). Εξετάζεται το ατομικό αναμνηστικό. Ερευνούμε αν η επιληψία είναι ιδιοπαθούς ή άλλης αιτιολογίας (ενδοκρανιακοί όγκοι, μετά από τραυματισμό ή ΚΕΚ, λοιμώξεις του ΚΝΣ, σήψη, λήψη αλκοόλ ή φαρμάκων ή αποχή από αυτά, επιπλοκές του ΣΔ, ανοσολογικά αίτια, κ.ά.).

Εξετάζουμε αν ο ήδη επιληπτικός ασθενής λαμβάνει κανονικά τη φαρμακευτική αγωγή του και εάν έχει υπάρξει μεταβολή στη συχνότητα των κρίσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Status Epilepticus (SE): Ως «**επιληπτική κατάσταση**» ορίζεται η οξεία εμφάνιση συνεχών ή επαναλαμβανόμενων επιληπτικών κρίσεων, χωρίς επαναφορά στην αρχική κατάσταση, και η οποία έχει ως αποτέλεσμα παρατηρούμενη ή υποκειμενικά αντιληπτή αισθητική, κινητική ή/και νοητική δυσλειτουργία, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών. Η διάρκεια των 5 λεπτών αποτελεί το λειτουργικό όριο, καθ' ότι πέρα από αυτό αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος μόνιμης νευρωνικής βλάβης και θνησιμότητας. Όσο περισσότερο διαρκεί, χωρίς θεραπεία, μια επιληπτική κατάσταση, τόσο δυσκολότερα αντιμετωπίζεται. Το SE μπορεί να είναι: **γενικευμένο τονικοκλονικό** (η πιο επικίνδυνη μορφή - συχνά απειλητική για τη ζωή), **εστιακό με διαταραχή συνείδησης**, και **μη σπασμωδικό** που απαιτεί ΗΕΓ για τη διάγνωση.



Διαφορική διάγνωση: Επιληπτική κρίση από λοιμώδες αίτιο (π.χ. σήψη, τέτανος, λύσσα) ή μεταβολική διαταραχή (υπογλυκαιμία, υπασβεστιαμία, ουραιμία, πορφυρία, τοξίκωση από κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη ή αλκοόλ), συγκοπτικό επεισόδιο, επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες, πυρετικοί σπασμοί, ημικρανία με αύρα, μετά από ΚΕΚ, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο - ΤΙΑ, εκλαμψία, ναρκοληψία, ψυχικές διαταραχές (σύνδρομο υπεραερισμού, κρίση πανικού, κ.ά.).

Θεραπευτική παρέμβαση

- ✓ Η έγκαιρη χορήγηση αποτελεσματικής αντιεπιληπτικής θεραπείας, εντός 5 έως 10 λεπτών, έχει καταδειχθεί από πλήθος μελετών ότι αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την πρόληψη της εκδήλωσης επιληπτικής κατάστασης (*status epilepticus*), καθώς και της σχετιζόμενης με αυτή νευρωνικής βλάβης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δυνητικά μόνιμη εγκεφαλική διαταραχή.
- ✓ Έχει επίσης δείχθει ότι η δραστηριότητα των αντιεπιληπτικών φαρμάκων (ΑΕΦ) είναι υψηλότερη (ποσοστό απόκρισης 80%) όταν η θεραπεία ξεκινά εντός 30 λεπτών από την έναρξη της κρίσης και η αποτελεσματικότητά τους μειώνεται σταδιακά όσο καθυστερεί η θεραπευτική παρέμβαση.
- ✓ Η πρώτη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων σχετίζεται σαφώς με καλύτερη έκβαση. Για αυτό εφαρμόζεται άμεσα το κατάλληλο θεραπευτικό πρωτόκολλο, χωρίς χρονοτριβή ή δισταγμό και κυρίως χωρίς να περιμένουμε τη διακομιδή του ασθενή στο νοσοκομείο για εκτίμηση από ειδικό.

1. Συνήθως, τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με τον ασθενή η επιληπτική κρίση έχει παρέλθει, εκτός των περιπτώσεων που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με Status Epilepticus.
2. Μεριμνούμε για τη βατότητα των αεραγωγών (Α). Αφαιρούμε τεχνητές οδοντοστοιχίες, εφαρμόζουμε στοματοφαρυγγικό ή ρινοφαρυγγικό αεραγωγό (βλ. σελ. 256-257), ενώ ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια θέση ανάληψης, μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.
Δεν ασκούμε έντονη δύναμη ή πίεση στο στόμα του ασθενούς, ενώ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η τοποθέτηση ειδικού στοματικού στροφικού διαστολέα (*Moulder-Spencer*) ή ειδικής ελαστικής σφήνας (*Excell-Spencer*) για τη διάνοιξη του στόματος του ασθενούς.
Ουδέποτε επιχειρείται η διάνοιξη του στόματος με τα δάκτυλα ή με αυτοσχέδια εργαλεία!
Αναρροφούμε τα εμέσματα ή τα πύγματα αίματος που πιθανώς υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα από τραυματισμό κατά την πτώση ή από ακούσιο δάγκωμα της γλώσσας.
3. Χορηγούμε O₂ στα 4-8 lt/min, με στόχο να διατηρούμε το SpO₂ > 90% και στη συνέχεια ρυθμίζεται η ροή O₂ αναλόγως των αερίων αίματος ή του SpO₂ (*παλμική οξυμετρία*)· (Β).
4. **Μέτρηση γλυκόζης, με Dextro-stick δακτύλου, για να αποκλειστεί η υπογλυκαιμία.**
Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, T °C). Εκτελούμε ΗΚΓ. Συχνά παρατηρείται φλεβοκομβική ταχυκαρδία ή PSVT και σπανιότερα βραδυαρρυθμία ή VF (*επί SUDEP*).
5. Δύο 3way ευρείες (#16-18G) φλεβικές γραμμές, με 500 ml D₅W στη μία εξ αυτών· (C).
6. Χορηγούμε 1-2 amp. **Διαζεπάμη** (*Stedon* 10 mg/amp.) σε ορό 100-250 ml NaCl 0,9%, (iv) στάγδην, σε διάστημα 20-30 λεπτών και επαναλαμβάνουμε επί status epilepticus.
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **Λοραζεπάμη**, ήτοι 1-2 amp. *Tavor* 4 mg/amp. σε ορό 100 ml N/S σε αργή (iv) έγχυση. Εναλλακτικά, επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί **Μιδαζολάμη** (*Dormicum*), χορηγώντας αρχικά 1-2,5 ml (από την αμπούλα 5 mg/5 ml). Προσοχή στην αναπνευστική καταστολή! [*Μην ξεχνάμε ότι η κατασταλτική δράση των Βενζοδιαζεπινών (BZDs) αναστρέφεται άμεσα με τη χορήγηση Φλουμαζενίλης (Anexate)*].
7. Προς επίρρωση της δράσης των Βενζοδ/πινών, χορηγείται **Λεβετιρακετάμη** (*Keppra*) σε δόση: 60 mg/kg, (max: 4500 mg) σε 100 ml N/S, εντός 10 λεπτών. Αντ' αυτής χορηγείται **Epanutin** 3-5 amp. 250 mg, εντός 500 ml N/S, με ρυθμό 20-30 mg/min (σε 45-60 min), υπό συνεχή ΗΚΓφικό έλεγχο· (η Φαινυντοΐνη χορηγείται πάντοτε σε διάλυμα NaCl 0,9% και όχι στη γραμμή του D₅W, γιατί τα διαλύματα γλυκόζης προκαλούν καθίζηση του φαρμάκου).
8. Επί **Status Epilepticus**, κι εφόσον έχει ήδη χορηγηθεί η αρχική θεραπεία για τις κρίσεις και για όσο διάστημα διαρκεί η διακομιδή, μπορεί να χορηγηθεί **Φαινοβαρβιτάλη**, ήτοι: 1-2 tabs. *Gardenal* 100 mg ή 2-4 ml oral sol. *Kaneuron* (μέσω του σωλήνα Levin) στους ενήλικες στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο κρίσεων ή drops 0,5-2 ml *Kaneuron* στα παιδιά. (Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πιθανή καταστολή του αναπνευστικού κέντρου, από τη συνδυασμένη χορήγηση των Βενζοδιαζεπινών και της Φαινοβαρβιτάλης).